

40. PRÁCTICA 1 EL MARCO CÓLICO

DURACIÓN : 03:16

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

En este video, la práctica del marco cólico se explora a través de puntos de apoyo cruciales como la arteria mesentérica y el ángulo cólico izquierdo. Los ponentes enfatizan la motilidad intestinal y su vínculo con los planos psíquico y emocional, demostrando cómo ciertas tensiones pueden reflejar desequilibrios internos como la ptosis o disfunciones viscerales. Se subraya la importancia de la normotensión abdominal, abordando los problemas de hipertensión e hipotensión. También se tratan las conexiones entre el colon transversal y las certezas personales, así como el impacto de los excesos alimentarios en el bienestar, ofreciendo a estudiantes y terapeutas claves para un enfoque integrador y liberador.

PRÁCTICA 1: EL MARCO CÓLICO

En esta práctica, exploraremos los **puntos de apoyo** esenciales en el marco cólico.

El **primer punto de apoyo** es la **arteria mesentérica**. Luego, el **segundo punto de apoyo** se sitúa en el **ángulo cólico izquierdo**, que está fijo. El **tercer punto de apoyo** se encuentra en profundidad. Finalmente, el último punto de apoyo está ligado a la dinámica del intestino, que se mueve en sentido inverso.

El movimiento que observamos es un movimiento de **motilidad**. A partir de este punto, podemos empezar a recorrer una **historia**. Inmediatamente me siento atraído hacia el **estómago**, el **bazo** y el ángulo cólico izquierdo. Este punto de apoyo está reequilibrando un **plano psíquico** bastante profundo. Es posible que busque acercarse a un **fulcro** más adelante para recuperar información.

Este punto está en equilibrio entre el **plano aórtico** y el **plano esplénico**. Es un plano de integración, un inconsciente que desea aflorar a la superficie, pudiendo expresarse en forma de **sueño** o de **pesadilla**. Al colocar el punto de apoyo en el lado izquierdo, busco obtener cierta **libertad**.

El punto final se sitúa aquí. Normalmente, la **tensión epigástrica** debe ser ligeramente superior a la **tensión hipogástrica**. Siempre se trata de una búsqueda de **normotensión abdominal** o de **hipotensión abdominal**. Si, durante mi palpación, constato que la tensión hipogástrica es superior a la tensión epigástrica, esto indica un sistema de **ptosis**.

En este caso, debo trabajar en un sistema de **reequilibrio viscerospacial** o fluido. En caso de **hipertensión**, es necesario liberar los fluidos. Por el contrario, para la **hipotensión**, se requiere una relajación, lo que implica reintegrar el sistema viscerospacial para devolverle la **dinámica** y aumentar la fuerza.

Es importante señalar que los **excesos alimentarios** aún pueden mejorarse. Al ascender, observo un ángulo que se forma, y al descender, me dirijo hacia mi **zona de alegría**. Si los problemas no se resuelven, esto puede llevar a la **zona de ira**.

El **colon transverso** representa mis **certezas** en la vida. Si estas certezas no se resuelven, se transforman en **dudas**. Al ascender, me enfrento a la **zona de confianza**, donde se encuentran mis **angustias**. El ángulo aquí es lo que se llama el **grillete del culpable**, que es esencial liberar.

Finalmente, al descender, abordo la **búsqueda de mi independencia**, un proceso por el cual debo ser totalmente libre de mis **padres**.

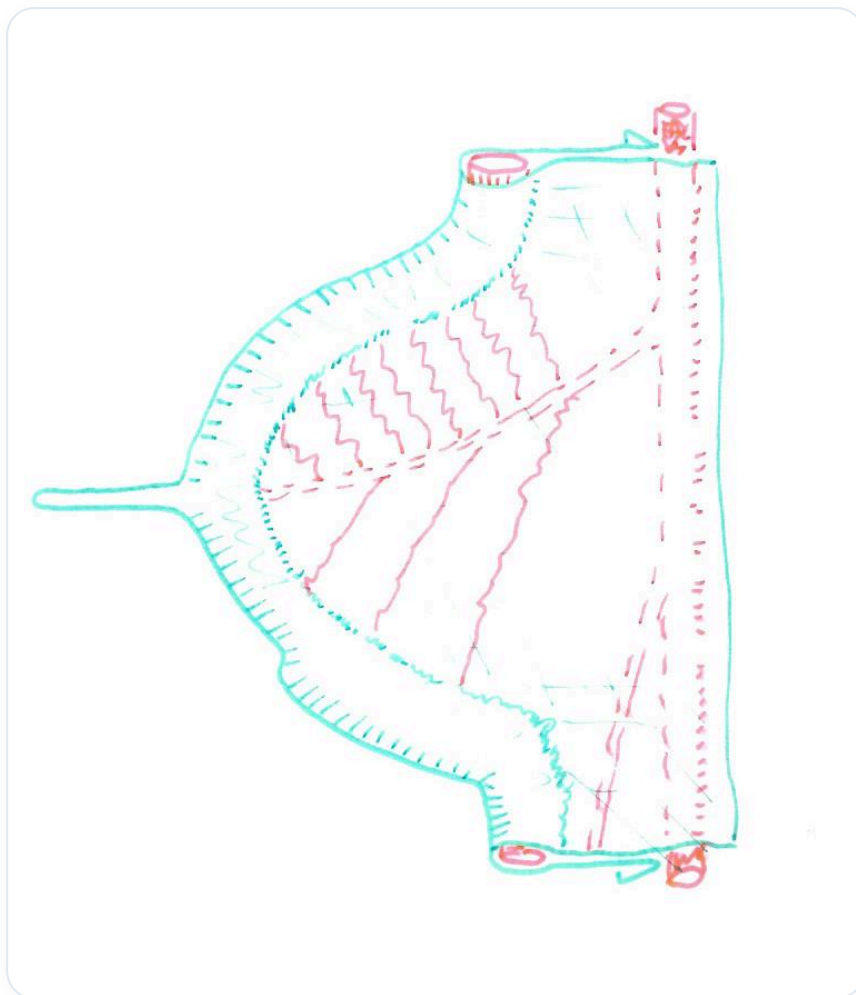


FIG. — *Tubo digestivo embrionario*